健康 · 12 · 妈妈与产后

产后浑身酸痛：是“月子病”吗？能好吗？

妈妈手、手麻、肩颈、腰和骨盆；为什么出了月子才疼；怎样抱、怎样喂、怎样练

约 1.9 万字 · 细读约 40 分钟 · 33 章 · 36 条资料出处

生完孩子，月子里没干重活、也没受凉，出了月子却手指、手腕、肩颈、腰、胯、脚趾一处接一处地酸痛，几天也消不掉。有人说这是“月子病”，好不了。真是这样吗？这一篇先摆数据，再讲为什么出了月子反而疼，然后一处一处讲是什么、怎样分辨，哪些情况要查血；最后用最多的篇幅讲**怎样缓解、怎样治疗、怎样少受这份罪**。

先说结论

很常见

香港的调查里，过半的妈妈产后新出现手腕痛；北京产后 6 周，约三分之一有骨盆带痛

不是“月子病”

医学上没有一个病叫月子病；每一处疼都有名字、有原因、有办法。碰冷水不是主要原因

三股力量

重复抱孩子喂孩子、身体还没恢复、睡不够心里累，汇在一起才浑身酸痛

先改动作

手掌朝上托着抱，喂奶让孩子来就乳、身体处处有东西托着；这是最直接的办法

练回力量

针对性的稳定练习能减轻产后骨盆带痛；妈妈手可以戴护具，严重的打一针

随机试验

多数会好

大多数一点点好起来；手指脚趾小关节肿痛、早上僵硬超过一小时的，去查一次血

下面先讲为什么，再一处一处分辨，然后讲怎样缓解和治疗。医学研究都在 PubMed 上核对过摘要；“编者的理解”只供参考。**本篇不能代替医生的诊断和处方；吃药、打针一定先问医生。**

目录

└ 第一部分 · 先把问题摆上桌

01 小林的七十天
02 很多妈妈都这样
03 “月子病”是什么?
第二部分 · 为什么出了月子反而更疼
04 三股力量汇在一起
05 第一股：带孩子是一份重复劳动
06 第二股：身体还在恢复
07 第三股：睡不够、心里累
08 碰了冷水、激素，是不是原因?
第三部分 · 逐个部位：是什么，怎样分辨
09 疼痛地图：哪里疼，可能是什么
10 拇指根、手腕：妈妈手
11 手指发麻：腕管，还是脖子?
12 肩颈：喂奶的姿势
13 腰：抱孩子的“支点”
14 胯和屁股两侧：骨盆带痛
15 脚和脚趾：站久了的酸
第四部分 · 哪些情况要查血、要马上去医院
16 浑身酸痛：要排除的几种病
17 这些情况，要马上去医院
第五部分 · 怎样缓解、怎样治疗
18 缓解和治疗：先看全貌
19 抱孩子：换个手法
20 喂奶：让身体处处有东西托着
21 冷敷、热敷和护具
22 运动：为什么有用
23 一套温和的练习（参考）
24 止痛药：哺乳期能不能吃?
25 打针和手术
26 中医、针灸、推拿
27 睡眠：一家人接力
28 心情：疼和低落常常一起来
29 吃什么？补什么?

└ 第六部分 · 能不能好，要多久
  └ 30 大概多久会好?
  └ 31 越怕动，越难好
└ 第七部分 · 一家人一起
  └ 32 一家人一起，让妈妈少疼一点
  └ 33 结语：慢慢引导那乳养小羊的

第一部分

先把问题摆上桌

01 小林的七十天

小林生完孩子七十天了。

月子里，有一次洗吸奶器，手碰了冷水。后来手指就开始疼，像腱鞘炎。她想：那就不碰冷水了，养一养就好。

月子里有几天，看孩子站得久了一点，脚趾抓地的时候也酸。出了月子，这两处都没好。

出了月子，她开始自己带孩子。手腕疼了起来，肩颈也疼——夜里躺着喂奶，一个姿势一躺就是很久。手指头开始发麻。抱孩子的次数多了，腰也疼。好不容易感觉恢复得不错，出去多走了走，胯骨又疼了。

“浑身的关节、肌肉都疼。”她说，“又不像运动以后的那种酸，过几天就消了。它一直在那里。”

有人跟她说：“这是月子病，好不了的。”她很担心。

小林是编者为了说明而写的人物，综合了很多妈妈的经历。她心里的问题，也是很多妈妈的问题：

- 月子里没干重活，也没受凉，**为什么出了月子反而疼？**
- 这是不是“月子病”？**能不能好？要多久？**
- **怎样缓解？怎样治疗？**怎样少受这份罪？

先说结论：**这些疼大多数是能好的，也有办法减轻。**它们不是一种神秘的“月子病”，而是几种有名字、有原因、有办法的毛病，赶在同一段时间里来了。

这一篇怎样读

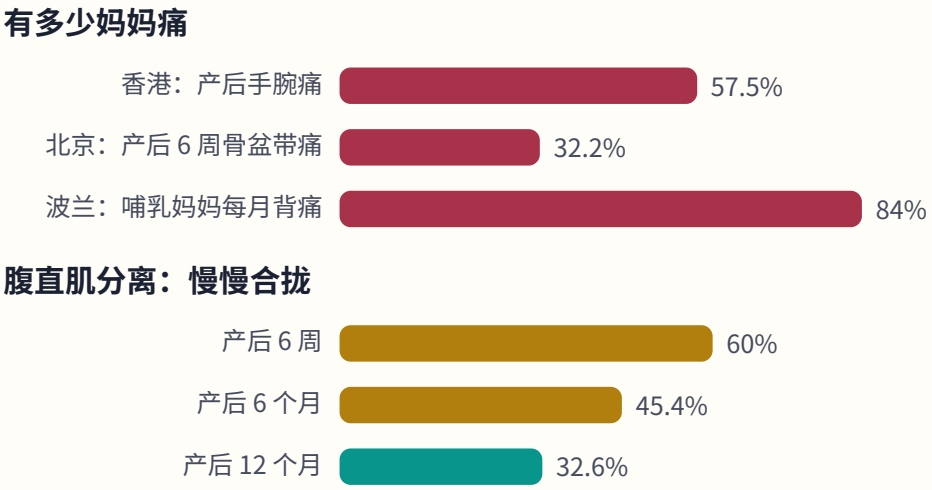
- **想知道为什么，**请读第二部分。
- **想知道自己是哪一种，**请读第三部分，开头有一张“疼痛地图”（见第 9 章《疼痛地图：哪里疼，可能是什么》）。
- **最想知道怎么办的（这是全篇的重点），**请直接读第五部分。
- **先看一眼第四部分：**有几种情况要查血，有几种要马上去医院。
- **资料都有出处。**医学研究都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，点正文里的小数字可以看到出处。
- **分清证据的分量。**“随机对照试验”是把人随机分成两组来比，最有说服力；“调查研究”只能看出“有关联”。文中会说明。
- **编者的理解**会标出来。**这一篇不能代替医生的诊断和处方**；吃药、打针，都要先问医生。

02 很多妈妈都这样

先看几项研究。它们来自不同的地方，但说的是同一件事：**产后的酸痛非常普遍。**

- **手腕：**香港中文大学访问了 259 位妈妈，产后 2 个月打电话问。**57.5% 产后新出现了手腕痛**；其中 84% 到第二个月还在痛。一多半两只手都痛，多数痛在拇指一侧。第一胎的妈妈更常见[1]。
- **骨盆和胯：**北京一家医院调查了 1,038 位产后 6 周的妈妈，**32.2% 有骨盆带痛**；痛的妈妈里，一半痛在骶髂关节（屁股上方两侧），七成多形容是“酸痛”[2]。
- **背和脖子：**波兰调查了 395 位哺乳的妈妈，**84% 每个月至少背痛一次**；每周都痛的，脖子 48%、腰 66%[3]。
- **腰和骨盆，放大来看：**一篇系统综述汇总了很多研究：孕期约 45%、产后约 25% 的妇女有腰痛或骨盆带痛；去掉轻微的，数字少约两成；产后严重的约 7%[4]。

图 1 产后酸痛：很多妈妈都有



Sit 2017、Li 2024、Ratajczak 2024、Sperstad 2016

所以，如果你正这样疼着，**你不是一个人，也不是你做错了什么。**

还有一个常被忽略的事实：很多妈妈**同时疼好几处**。北京的调查里，有骨盆带痛的妈妈，约四分之一疼在不止一处[2]。“浑身都疼”，并不奇怪。

03 “月子病”是什么?

“月子病”是民间的说法。中医有“产后身痛”“产后风”的说法，认为和产后气血虚、受了风寒有关。

但在医学上，**没有一个病叫“月子病”**。妈妈们说的“月子病”，其实是好几种不同的毛病装在一个筐里：

- 拇指根、手腕疼：多半是**妈妈手**（一种腱鞘炎）；
- 手指发麻：常是**腕管综合征**，也可能和颈部有关；
- 肩颈、腰疼：多和**姿势和负荷**有关；
- 胯和屁股两侧疼：常是**骨盆带痛**；
- 还有少数，是**产后甲状腺炎、类风湿关节炎**这类需要查血的病（见第 16 章《浑身酸痛：要排除的几种病》）。

把筐打开、一样一样分清楚，好处很大：每一样都有自己的原因，也有自己的办法。

“月子病好不了”？

编者没有找到任何研究支持“月子病一辈子好不了”这个说法。下面会看到，大多数产后的酸痛会一点点好起来（见第 30 章《大概多久会好？》）。这句话最大的伤害，是让妈妈们害怕、不敢动——而**越不敢动，反而越难好**（见第 31 章《越怕动，越难好》）。

第二部分

为什么出了月子反而更疼

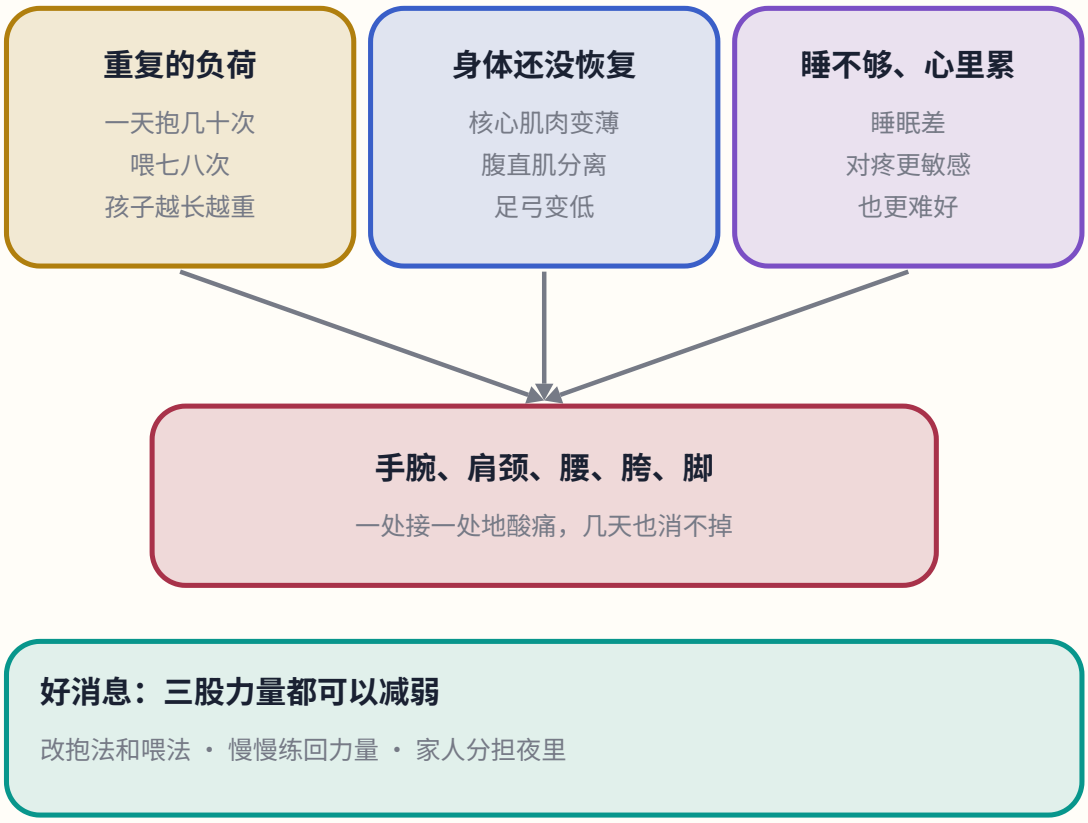
04 三股力量汇在一起

小林最想不通的是：月子里没干重活，也没受凉，为什么**出了月子反而疼**？

其实时间正好对得上。**出了月子，正是她开始自己带孩子的时候。**

编者把原因归成三股力量。哪一股单独来，身体都扛得住；三股一起来，就扛不住了：

图 2 为什么出了月子反而更疼：三股力量汇在一起



碰冷水：没有研究说明它会造成关节病 · 编者整理

1. **重复的负荷。**抱、放、喂、拍嗝、换尿布、洗奶瓶，一天几十次。孩子还一天天变重。
2. **身体还没恢复。**孕期撑开的腹肌、变松的足弓、变薄的核心肌肉，要好几个月才慢慢回来。
3. **睡不够、心里累。**夜里喂奶，觉被切成一段一段。睡不够，人会对疼更敏感，疼也更难消。

下面一股一股讲。

05 第一股：带孩子是一份重复劳动

想一想一天里，手要做多少次同样的动作：

- 从床上抱起、放下：几十次；
- 喂奶：七八次，每次托着孩子的头十几二十分钟；
- 拍嗝、哄睡：抱着走来走去；
- 洗奶瓶、拧毛巾、换尿布。

这和工厂里做重复动作的工人很像。研究职业病的人都知道：**同一个动作重复几千次，比偶尔搬一次重物更伤肌腱和关节。**

而且孩子越来越重。研究发现，孩子越大，妈妈手越常见：美国的一项调查里，手腕痛而且自测阳性的那一组，孩子的平均年龄最大[5]；巴基斯坦调查了 190 位照顾婴儿的人，孩子的月龄、一天抱起的次数，都和妈妈手有关[6]。

月子里，往往有老人或月嫂帮忙；出了月子，活儿一下子都落到妈妈身上。**“出了月子才疼”，正是这个原因。**

还有一点：新手妈妈抱孩子，常常是“掐着”抱——拇指张开、虎口卡住孩子的腋下往上提。这个动作对手腕拇指一侧的肌腱最不友好（见第 10 章《拇指根、手腕：妈妈手》）。

06 第二股：身体还在恢复

怀孕九个月，身体为了容纳孩子，做了很多改变。生完孩子，这些改变不会一夜之间退回去。

腹肌和核心。腹部正中两条腹直肌会被撑开，叫“腹直肌分离”。挪威跟踪了 300 位第一胎的妈妈：产后 6 周约 60% 有分离，6 个月约 45%，12 个月约 33%——一年里慢慢合拢[7]。

广州一项超声研究比较了产后腰痛的妈妈和不痛的妈妈：腰痛的人，腰背深层的多裂肌更薄，核心稳定性更差，腰围更大[8]。核心就像一圈“天然的护腰”；它还没恢复，抱孩子的力量就更多压在腰椎和韧带上。

脚。美国一项研究在孕早期和产后 19 周量了 49 位妇女的脚：**足弓变低、变软，脚变长**，而且第一胎的变化最明显，产后并没有完全回去[9]。足弓低了，久站时脚掌和脚趾的负担更重——小林“站久了脚趾抓地酸痛”，可能和这个有关（编者的理解）。

体力。怀孕后期和月子里活动少，肌肉的力量和耐力都下降了。出了月子突然要整天抱孩子，就像很久没运动的人突然去搬家。

— 腹直肌分离会不会造成腰痛?

不一定。挪威那项研究里，产后 12 个月，有分离和没有分离的妈妈，腰和骨盆的疼痛差不多[7]。所以不必因为摸到肚子中间有一道缝就害怕。不过同一项研究发现，每周搬重物 20 次以上的妇女，分离更常见。编者的理解：腹直肌分离是“身体还在恢复”的一个标志，提醒我们慢慢练回核心，而不是一个必须马上处理的病。

07 第三股：睡不够、心里累

这一股最容易被忽略，却可能最要紧。

美国约翰斯·霍普金斯大学的学者综述了 2005 年以后的研究：**睡眠差能预测新的慢性疼痛出现、旧的疼痛加重**；而且“睡不好导致疼”比“疼导致睡不好”的关系更强。实验里，睡眠被打断，身体自己“压住疼痛”的能力会变弱[10]。

新妈妈的觉，是被切成一段一段的。夜里两三个小时醒一次，白天也难补。**同样的劳损，睡不够的人觉得更疼、好得更慢。**

心情也一样。北京那项调查里，骨盆带痛和产后抑郁症状常常一起出现[2]。美国一项 1,288 位产妇的研究发现，生产后头几天疼得厉害的妈妈，8 周后持续疼痛的风险约高 2.5 倍，产后抑郁的风险约高 3 倍[11]。疼、睡不好、心情差，会互相拉着往下走。

反过来也一样：**睡好一点、心里轻松一点，疼也会轻一点。**这就是为什么后面讲缓解的时候，会专门讲睡眠和家人分担（见第 27 章《睡眠：一家人接力》）。

08 碰了冷水、激素，是不是原因?

很多妈妈像小林一样，把手指疼归到“月子里碰了冷水”。

编者没有找到研究说明，产后碰冷水会造成腱鞘炎或关节病。冷会让人当时觉得手更僵、更疼，但它不会在关节里留下什么“寒气”。

那为什么正好是碰了冷水以后开始疼？编者的理解：那段时间，手正好开始频繁地洗吸奶器、拧东西、抱孩子。冷水是当时最显眼的一件事，就被记成了原因。真正在磨损肌腱的，是每天几十次的重复动作。

激素呢? 孕期身体的激素变化，会让关节周围的组织变松、积水，这是孕期腕管综合征常见的原因之一[12]。但对妈妈手，美国那项研究认为，哺乳的激素变化**不是重要原因**，带孩子的动作才是主角[5]。以色列的一项研究发现，第一胎、怀孕超过 40 周、体重偏重的妈妈产后更容易得妈妈手，而孩子的出生体重、是不是双胞胎反而没有关系[13]——原因可能不止一个，研究者也说还没完全弄清楚。

“捂月子”呢？台湾的传统是月子里不洗澡。台湾一项 358 位产妇的研究发现，产后洗温水淋浴（40 到 43 摄氏度、约 20 分钟）的妈妈，疲劳反而减轻[14]。这不是随机试验，但至少说明温水洗澡没有伤害。一篇综述也发现，很多东亚妈妈已经按实际情况调整了坐月子的做法[15]。

编者的理解

月子里注意保暖、休息、吃好，本身是好的。但不必害怕碰水；更不必把出了月子以后的疼，都算到月子里那一次冷水上。把注意力放在**每天重复了几十次的动作**上，才找得到办法。

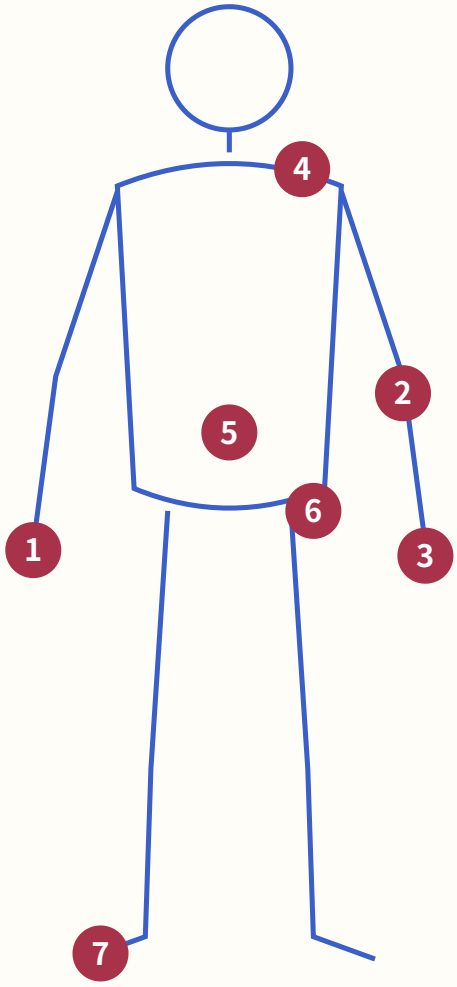
第三部分

逐个部位：是什么，怎样分辨

09 疼痛地图：哪里疼，可能是什么

先对着这张图，找一找自己疼的地方。下面几章一处一处讲。

图 3 产后疼痛地图：哪里疼，可能是什么



1 拇指根、手腕拇指侧
妈妈手（腱鞘炎）

2 手指发麻
腕管综合征 · 或颈部

3 手指根疼、弯伸卡住
扳机指

4 肩颈
低头喂奶 · 同一姿势太久

5 腰
核心变薄 · 弯腰抱孩子

6 胯、屁股两侧
骨盆带痛（骶髂关节）

7 脚、脚趾
久站 · 足弓变低

示意图 · 编者根据本篇引用的研究整理

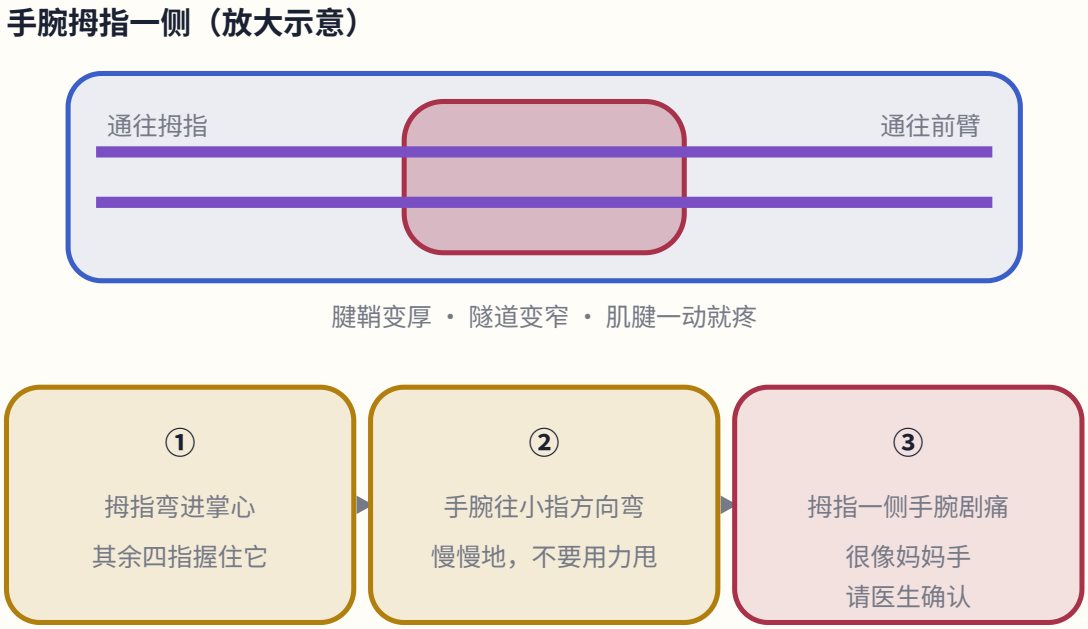
要说明：**这张图只是帮助分辨，不能代替医生的检查。**同一个地方疼，可能有不同的原因；有几种情况要查血（见第 16 章《浑身酸痛：要排除的几种病》）。

10 拇指根、手腕：妈妈手

拇指根和手腕拇指一侧疼，拇指一用力、手腕一转就疼，拿杯子、拧毛巾、抱孩子都疼——这多半是**妈妈手**，医学上叫“桡骨茎突狭窄性腱鞘炎”，英文叫德奎尔万腱鞘炎。

手腕拇指一侧，有两条管拇指张开和伸直的肌腱，一起穿过一条由腱鞘包着的窄隧道。抱孩子时拇指张开、手腕往小指方向弯，肌腱在隧道里来回摩擦；一天几十次，腱鞘发炎变厚，隧道变窄，一动就疼。

图 4 妈妈手：两条肌腱挤过一条窄隧道



为什么新妈妈多：抱孩子时拇指张开、手腕往小指方向弯，一天几十次；第一胎、孩子越大越常见。

示意图 · Sit 2017、Ferraro 2023、Daglan 2024

可以先自测：拇指弯进掌心，其余四指握住它，再把手腕慢慢往小指方向弯。如果拇指一侧的手腕剧痛，就很像妈妈手。这个动作常叫“芬克斯坦试验”。要医生确认。

谁更容易得：

- 第一胎的妈妈：香港的研究里约 2.6 倍[1]，以色列的研究里约 2.2 倍[13]；
- 孩子越大、一天抱起的次数越多[6][5]；
- 常用的那只手[6]。

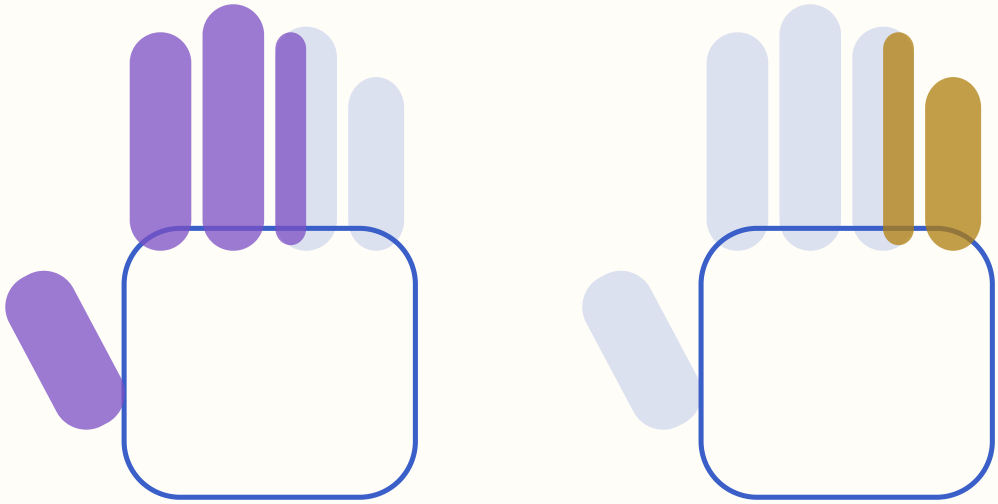
澳大利亚访问了 15 位得过妈妈手的第一胎妈妈。她们说：换尿布、洗澡、哄睡都受影响；**在得病以前，几乎没有人告诉过她们这件事**；医生给的护具，带孩子时又常常戴不住[16]。所以这一篇特别把“怎样抱”放在前面（见第 19 章《抱孩子：换个手法》）。

手指根部疼、手指弯了伸不直、伸的时候“咔哒”一下卡住，是另一种腱鞘炎，叫**扳机指**。道理相似：手指屈肌腱在掌根的“滑轮”里反复摩擦。也是减少握拧、必要时请手外科医生看。

11 手指发麻：腕管，还是脖子？

手指发麻，先看**麻在哪几根手指**。

图 5 手指发麻：看麻在哪几根



拇指、食指、中指（和半个无名指）

→ 多半是腕管综合征

小指和半个无名指

→ 肘部尺神经或颈部

麻木伴着肩颈痛、转头加重：要想到颈部

示意图 · 左手，手心朝向自己 · 编者整理

拇指、食指、中指麻，常在夜里麻醒，甩甩手会好一些：多半是**腕管综合征**。手腕掌侧有一条“腕管”，正中神经从里面穿过；手腕一直弯着、组织水肿，神经就被挤。

这在孕期非常常见，报道的比例从不到 1% 到 70%，差别很大，取决于怎样诊断[17]。多数在产后消退，**但哺乳的妈妈，有的要到断奶以后才好**[17][18]。

小指和半个无名指麻：可能是肘部的尺神经被压（比如抱孩子时肘一直弯着、压着），也可能和颈部有关。

麻木伴着肩颈痛、转头时加重、整条手臂发沉发麻：要想到颈部的神经根。长时间低头喂奶、侧躺时枕头太低，都可能让颈部受累（见第 12 章《肩颈：喂奶的姿势》）。

要去看医生的手麻

- 手越来越没力气，拿不住东西、扣不上扣子；
- 拇指根部的肌肉变瘪；
- 麻木一直不消，或越来越重。

这些说明神经被压得比较重了，要请手外科、骨科或神经科医生看，可能要做神经电图。

12 肩颈：喂奶的姿势

小林的肩颈疼，是从“躺着喂奶，一个姿势很久”开始的。这非常典型。

喂奶时，妈妈常常低着头看孩子，肩膀耸着，手臂悬着托孩子。一次十几二十分钟，一天七八次，加起来就是几个小时。

波兰那项研究发现：**每次喂奶时间越长、一天喂奶总时间越长，背痛越常见**。有意思的是，喜欢躺着喂的妈妈，颈痛反而比坐在椅子上喂的轻一些——前提是**头有东西托着**[3]。研究者的建议是：每次喂奶不要拖得比需要的更久；选一个身体每一处都有东西托着的姿势；侧躺、半躺时把头托好[3]。

约旦一项 493 位哺乳妈妈的研究也发现：很多妈妈腰、颈、肩、手都疼，影响心情和睡眠；而**大多数人从来没有人教过她们怎样喂奶姿势更省力**[19]。

编者的理解：躺着喂奶本身没有错，错在**枕头太低、一个姿势太久、肩膀悬空**。具体怎样调，后面讲喂奶的那一章细说（见第 20 章《喂奶：让身体处处有东西托着》）。

13 腰：抱孩子的“支点”

腰疼，常常是抱孩子抱出来的。

弯腰从床上、婴儿床里、地上把孩子抱起来；抱着孩子长时间站、走、晃；喂奶时弓着背——这些都让腰承受反复的弯曲和负重。

而这时候，“天然护腰”还没恢复：前面讲过，产后腰痛的妈妈，腰背深层肌肉更薄、核心更不稳[8]。

大多数产后腰痛是“机械性”的：动得不对、累了就疼，换个姿势、休息一会儿就轻一些。**它不是骨头坏了，也不是“受了风”。**

要注意的是另一类：夜里躺着不动也疼得醒过来、发烧、腿麻无力、大小便控制不住——这些要尽快去医院（见第 17 章《这些情况，要马上去医院》）。

14 胯和屁股两侧：骨盆带痛

小林说，恢复得不错以后出去多走了走，胯骨就疼了。这很像**骨盆带痛**。

骨盆是一个环：后面两侧是骶髂关节（屁股上方两侧的“小窝”附近），前面是耻骨联合。孕期为了生产，这个环会变得松一些；产后要几个月才慢慢稳下来。环不稳的时候，走得多、单腿站、跨大步、上下楼梯、在床上翻身，都可能疼。

北京的调查里，产后 6 周有骨盆带痛的妈妈，一半痛在骶髂关节，多数是酸痛，平均疼痛程度约 3 分（满分 10 分）[2]。广州的研究还发现：**以前腰痛或骨盆痛过的人，更容易得**（约 5 倍）；每天坐得越久越容易，**每天走得多一点反而少一些**[20]。

所以不是“走路害的”。编者的理解：是走得**一下子太多**，超过了骨盆当时能承受的量。办法不是不走，而是**分几次走、每次少一点，慢慢加**，同时练臀部和核心（见第 22 章《运动：为什么有用》）。

15 脚和脚趾：站久了的酸

抱着孩子站、走、晃，一站就是很久。脚掌和脚趾要一直“抓”着地，替身体找平衡。

前面讲过，怀孕会让足弓变低、变软，第一胎最明显，产后 19 周还没完全回去[9]。足弓低了，脚底的筋膜和脚趾的小肌肉负担更重，久站就酸。

可以做的：

- 在家也穿有足弓支撑、鞋底不太软的鞋，少光脚站在硬地上；
- 抱孩子时能坐就坐，少站着晃；
- 每天练一练脚：坐着用脚趾抓毛巾、踮脚尖慢慢起落（见第 23 章《一套温和的练习（参考）》）。

如果是**早上下床第一步脚跟最痛**，走几步反而好一些，可能是足底筋膜炎；如果脚趾的关节**又肿又热**，或者好几个脚趾、手指的小关节都肿，就要查血（见第 16 章《浑身酸痛：要排除的几种病》）。

第四部分

哪些情况要查血、要马上去医院

16 浑身酸痛：要排除的几种病

大多数产后的酸痛，是前面讲的劳损和恢复的问题。但**“浑身关节都疼”**，尤其是手指和脚趾的小关节都疼，医生会想到几种要查血才能分清的病。**查一次，是为了放心。**

一、产后甲状腺炎。产后一年内约 5% 的妇女会得，是自身免疫引起的甲状腺发炎[21]。典型的过程是三段：先有一到三个月甲状腺激素偏高（心慌、手抖、怕热、瘦），再有一段可长达半年的偏低，然后多数恢复正常；但每个人不一样，有的只有偏高或只有偏低[22]。甲状腺激素偏低时，人会乏力、怕冷、浑身酸、心情低落，很容易被当成“累的”。少数人会变成长期的甲减[21]。验一次甲状腺功能就能查出来，也能治。

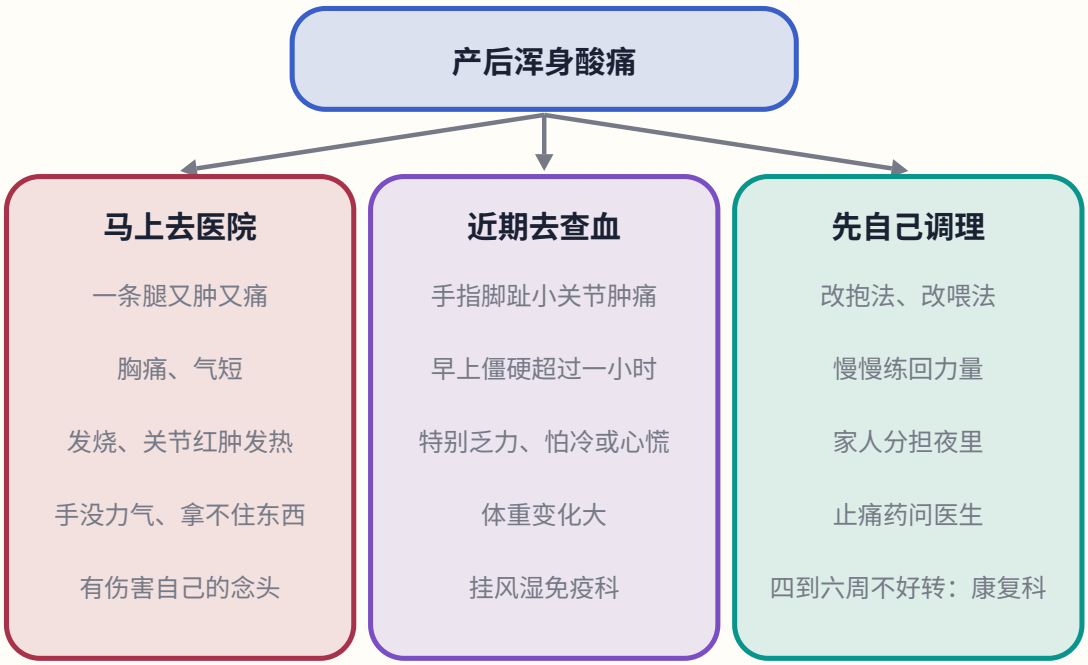
二、类风湿关节炎。它常从手指、脚趾的小关节开始，两边对称，早上起来关节僵硬，要活动很久才松开。英国一项研究发现，**产后头 3 个月，类风湿关节炎发病的风险约是平时的 5.6 倍**，第一胎之后更明显[23]；挪威的登记资料也显示，产后两年内确诊的比之后两年多（约 1.7 倍）[24]。要说明：**总体得这个病的人仍然很少**；但它越早治越好，所以值得查。

三、贫血和缺铁。生产失血、哺乳，都会消耗铁。贫血让人乏力、气短、头晕，肌肉也更容易累。产后贫血也是产后抑郁的危险因素之一[25]。

四、维生素 D 不足。维生素 D 不足和产后抑郁有关[25]；严重缺乏时也会骨头肌肉酸痛。查一下，缺就补。

五、产后抑郁。它不只是“心情不好”，也常常表现为浑身不舒服（见第 28 章《心情：疼和低落常常一起来》）。

图 6 浑身酸痛：先分三条路



Kamel 2014、Nguyen 2019、Silman 1992 · 编者整理

可以挂哪个科：小关节肿痛、早上僵硬，挂**风湿免疫科**；心慌手抖或特别怕冷乏力，挂**内分泌科**；不确定的，先挂产后复查的妇产科或全科，请医生转诊。

17 这些情况，要马上去医院

产后的身体有几种急事，不能等：

- **一条腿又肿又痛、发热发红，或者突然胸痛、喘不上气：**可能是血栓。美国加州 168 万次分娩的研究发现，产后 6 周内血栓的风险约是平时的 11 倍；7 到 12 周仍约 2 倍，绝对数字已经很低（每 10 万次分娩多约 3 例）；12 周以后就和平时差不多了[26]。产后两三个月的妈妈，如果有这些症状，**直接去急诊。**
- **发烧，或者某个关节突然又红又肿又热：**可能是感染，或急性的关节炎。
- **手脚越来越没力气、大小便控制不住、会阴部发麻：**可能是神经被压得很重。

- **夜里躺着不动也疼得醒过来，越来越重：**要查清原因。
- **心情一直很低落，有伤害自己或孩子的念头：**马上告诉家人、去医院，或拨打当地的心理援助热线。

这些不常见。但知道了，就不会耽误。

第五部分

怎样缓解、怎样治疗

18 缓解和治疗：先看全貌

这一部分是全篇的重点。先看全貌，再一样一样讲。

图 7 哪些办法有证据：从强到弱



编者根据本篇引用的研究整理

编者把办法分成三层：

1. **减负荷：**改抱法、改喂法、用工具分担（见第 19 章《抱孩子：换个手法》、第 20 章《喂奶：让身体处处有东西托着》）。这是最直接、最便宜、马上就能做的。
2. **帮修复：**冷敷热敷、护具、止痛药、必要时打针（见第 21 章《冷敷、热敷和护具》、第 24 章《止痛药：哺乳期能不能吃？》、第 25 章《打针和手术》）。让发炎的地方安静下来。

3. **练回来：**慢慢练回核心、臀部、肩背的力量（见第 22 章《运动：为什么有用》、第 23 章《一套温和的练习（参考）》）。这是让疼不再回来的根本。

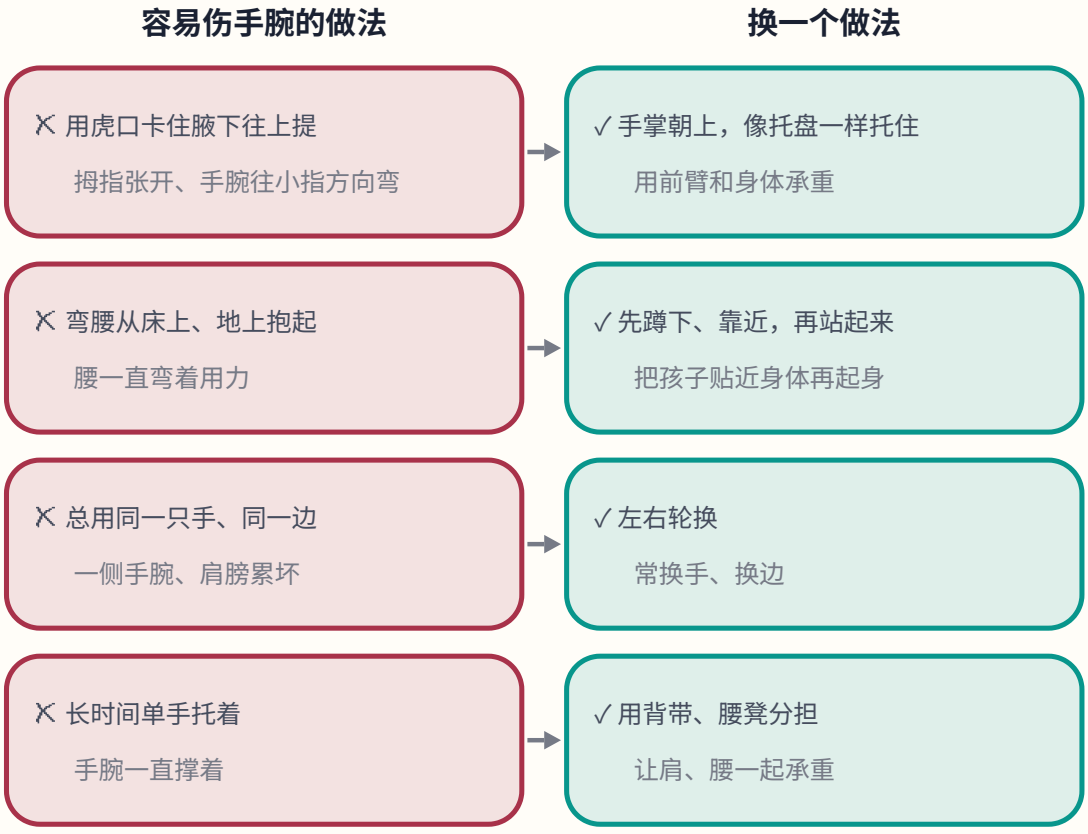
再加上两样常被忘记的：**睡眠**和**心情**（见第 27 章《睡眠：一家人接力》、第 28 章《心情：疼和低落常常一起来》）。

小林已经开始做产后恢复的拉伸，以前拉不开的动作现在能拉开了——**这是对的方向**。下面要做的，是把“减负荷”补上，再从拉伸慢慢加到力量练习。

19 抱孩子：换个手法

对手腕来说，**“怎样抱”比“抱多少”更要紧。**

图 8 抱孩子：换个手法，手腕少受累



编者根据本篇引用的研究和康复常规整理

1. 手掌朝上，像托盘一样托。把孩子抱起来时，一只手从下面托住屁股，另一只手掌心朝上托住头颈和背，用前臂承重，把孩子贴近自己的身体。少用虎口卡住孩子的腋下往上提——这个动作让拇指张开、手腕往小指方向弯，正好挤着妈妈手那两条肌腱。

2. 先靠近，再抱起。从床上抱孩子，先坐到床边或蹲下，把孩子挪到身边，再抱起来站直。不要站着弯腰、伸长手臂去够。

3. 用工具分担。背带、腰凳、哺乳枕，都能把重量从手腕转到肩、腰和身体上。换尿布的台子高一点，少弯腰。

4. 左右轮换。常用的那只手更容易得妈妈手[6]。有意识地换手、换边。

5. 少拧、少掐。拧毛巾、拧奶瓶盖，能交给家人就交给家人；能用工具（比如开瓶器）就用。

6. 抱一会儿，放一会儿。孩子醒着的时候，可以让他在安全的地方趴一会儿、躺一会儿，妈妈也歇一歇手。

编者的理解

这些办法没有专门的随机试验，是根据妈妈手的道理（见第 10 章《拇指根、手腕：妈妈手》）和康复的常规整理的。澳大利亚的妈妈们说，最希望的是“早点有人告诉我”[16]。所以，如果身边有孕妇，可以把这一章转给她。

20 喂奶：让身体处处有东西托着

一个原则：**孩子来就乳，不是人去够孩子；身体每一处都有东西托着。**

图 9 喂奶：让身体每一处都有东西托着



Ratajczak 2024、Aburub 2022 · 编者整理

坐着喂：

- 选有靠背的椅子或沙发，背后垫一个枕头，让背靠实；
- 脚下垫一个小凳子，膝盖略高过臀部，腰就不会往前弓；
- 腿上放哺乳枕或枕头，把孩子垫到乳房的高度；托孩子的那只手的肘部，也放在枕头或扶手上；
- 肩膀放松、放下来，不要耸着。可以偶尔低头看孩子，但不要一直低着。

侧躺喂：

- 头下的枕头要够高，让脖子和背成一条直线，不歪、不折；
- 背后再垫一个枕头靠着，两腿中间也可以夹一个；
- 孩子侧过来面向妈妈，用小毯子或枕头在孩子背后挡一下，妈妈的手臂就不用一直撑着。

每次、每天：

- 不要一个姿势坚持太久。研究发现，每次喂奶时间越长，背痛越常见[3]。孩子吃饱了、只是含着玩的时候，可以结束；
- 坐、躺、半躺换着来，左右两边轮换；
- 喂完慢慢转转头、耸耸肩、把肩胛骨往后夹几下。

安全提醒：侧躺喂奶时妈妈很容易睡着。要确保床面平整、没有厚被子枕头盖住孩子；太困的时候，请家人在旁边照看，喂完把孩子放回自己的小床。

21 冷敷、热敷和护具

冷敷还是热敷?

老实说，证据不强。一篇系统综述汇总了慢性腰痛的各种理疗，认为热敷、冷敷的资料都太少，下不了确定的结论[27]。

编者的理解：两样都没有什么害处，**哪个舒服用哪个**。一般的经验是：

- 刚疼起来、有点肿、一动就刺痛的（比如妈妈手刚发作），冷敷 10 到 15 分钟，用毛巾包着冰袋，不要直接贴皮肤；
- 酸、僵、紧的（比如肩颈、腰），热敷或洗个热水澡，让肌肉松下来。

用热水洗手、洗澡都没问题，不必怕（见第 8 章《碰了冷水、激素，是不是原因？》）。

护具：

- **妈妈手：**可以戴“拇指人字形护具”，把拇指和手腕固定在休息的位置，让发炎的肌腱歇一歇。澳大利亚的妈妈们说，带孩子时护具常常戴不住[16]；编者的理解：可以先在睡觉和做家务时戴。
- **腕管综合征：**晚上戴让手腕保持平直的护腕，是公认的第一步，配合神经和肌腱的滑动练习效果更好；不过研究的证据强度偏低[12]。
- **骨盆带痛：**有的人戴骨盆带觉得走路更稳，可以试一试；但它不能代替练习。

22 运动：为什么有用

小林发现，做了产后恢复的拉伸以后，肩颈好多了。这不是心理作用。

运动对产后和孕期的腰痛、骨盆痛，有随机试验的证据：

- **挪威的试验（产后骨盆带痛）：**81 位产后骨盆带痛的妇女，随机分成两组，都做 20 周理疗；一组加上**针对性的稳定练习**（练腹横肌、多裂肌、臀部这些深层肌肉，让骨盆稳下来）。结果，练习组的疼痛明显更轻，功能障碍减少一半以上；**到产后一年仍然更好**，对照组几乎没有变化[28]。
- **考克兰综述（孕期）：**汇总了 34 个随机试验、5,121 位孕妇：各种运动可能减轻孕期腰痛；8 到 12 周的运动计划，让报告腰痛和骨盆痛的人少了约三分之一；不良反应都很轻微[29]。
- **慢性腰痛：**系统综述也发现，运动比一般照护更能减轻疼痛、改善功能[27]。

世界卫生组织 2020 年的指南，第一次专门给孕妇和产后妇女写了建议；对一般成年人，是每周 150 到 300 分钟中等强度的活动，再加上肌肉力量练习[30]。

为什么有用？编者的理解：

1. 把核心、臀部、肩背的力量练回来，同样抱一个孩子，分到每一块肌肉、每一个关节上的负担就小了；
2. 动起来，血液循环好，僵硬的肌肉松开；
3. 运动能改善睡眠和心情，而这两样本身就会放大或减轻疼痛（见第 7 章《第三股：睡不够、心里累》）。

原则：从轻到重，从短到长；疼痛不加重就慢慢加。练的时候有点酸是正常的；如果练完第二天疼得更厉害，就退一步。

23 一套温和的练习（参考）

下面是编者根据研究的思路和康复的常规整理的一套**参考**练习，不是处方。剖腹产的、有严重腹直肌分离或盆底问题的、疼得厉害的，**请先到医院的产后康复门诊**，让康复师按你的情况定。

每天挑几个做，加起来 15 到 20 分钟就够。可以趁孩子睡觉的时候做。

一、呼吸和核心（躺着就能做）

- **腹式呼吸：**仰卧屈膝，吸气时肚子轻轻鼓起，呼气时肚子慢慢收回、像要把肚脐往脊柱贴。10 次。
- **收腹加盆底：**呼气时，轻轻收紧盆底（像憋住小便），同时下腹往里收，保持 5 到 10 秒，正常呼吸，再放松。10 次。
- **臀桥：**仰卧屈膝，收腹后把屁股慢慢抬起，肩、髋、膝成一条线，停 3 到 5 秒再放下。10 次，2 组。骨盆带痛的人，膝间夹一个枕头。

二、肩颈和上背

- **收下巴：**坐直，下巴往后收（像做“双下巴”），后脑勺往上顶，停 5 秒。10 次。
- **夹肩胛：**两肩放松下沉，肩胛骨往后、往下夹，停 5 秒。10 次。喂完奶就做几下。
- **胸前拉伸：**站在门框边，手臂贴着门框，身体慢慢往前，感到胸前拉开，停 20 到 30 秒。

三、手和手腕

- **握拳伸展：**慢慢握拳、再把手指完全张开。10 次。
- **腕管的神经滑动：**手腕伸直、手指伸直，慢慢把手腕往后扳、拇指往外张，到有轻微牵拉感就停，再回来。5 到 10 次，不要硬拉。
- 妈妈手正在发炎、很痛的时候，**先休息和固定**，不要硬拉拇指；不太痛了再慢慢活动。

四、臀部和腿

- **侧躺抬腿（蚌式）：**侧躺屈膝，两脚并拢，上面的膝盖慢慢打开再合上。每边 10 到 15 次。练臀部，稳骨盆。
- **靠墙半蹲或扶椅子蹲起：**慢慢蹲下、慢慢站起，像抱孩子前蹲下的动作。10 次。

五、脚

- **脚趾抓毛巾：**坐着，用脚趾把地上的毛巾一点点抓过来。
- **踮脚：**扶着桌子，慢慢踮起脚尖再放下。10 到 15 次。

六、走路

- 推着婴儿车出去走。从每次 10 分钟开始，慢慢加到每次 20 到 30 分钟；骨盆疼的，**分几次走，步子小一点**，先不爬坡、少上下楼。

> **一 为什么练“深层”的肌肉？**
>
> 挪威那项试验练的是“针对性的稳定练习”：先学会单独收紧腹横肌、多裂肌和盆底这些深层肌肉，再在各种姿势和动作里保持它们收紧，最后加上臀部和背部的力量练习[28]。深层肌肉像一圈束腰，把骨盆和腰椎“箍”稳；表面的大肌肉负责出力。编者的理解：先稳、后力，是产后练习的顺序。

24 止痛药：哺乳期能不能吃？

很多妈妈宁可忍着，也不敢吃药，怕影响孩子。

美国家庭医师学会 2022 年的综述说：**哺乳期首选的止痛药是对乙酰氨基酚和布洛芬**[31]。它们进入乳汁的量很少，研究得也比较多。

所以，疼得影响睡觉、影响抱孩子的时候，**按说明书的剂量、短期吃一吃，是可以的**。但请注意：

- 先问医生或药师，尤其是有胃病、肾病、哮喘，或者在吃别的药的；
- 止痛药是让你能睡、能动、能练，**不是用来代替改动作和练习的**；
- 外用的止痛膏、止痛凝胶，可以抹在手腕、腰这些地方，但**不要抹在乳房附近**，免得孩子吃进去；
- 同一份综述也提醒：**草药补充剂有杂质的风险，对吃奶孩子的影响也缺少研究**[31]。别人推荐的“产后风”偏方、药酒，先问医生。

25 打针和手术

妈妈手：如果改抱法、戴护具几周还不见好，可以请手外科或骨科医生考虑**在腱鞘里打一针激素**。

- 一篇汇总了 16 个随机试验、1,206 位病人的分析发现：打针比单纯戴护具的成功率约高六成；**打针加护具，又比只打针更好**。作者建议打针作为第一线治疗，护具作辅助[32]。
- 另一篇综述汇总了超声引导下打针的研究（379 个手腕）：约 74% 完全缓解，18% 部分缓解；完全缓解的人里，后来约六分之一复发[33]。

哺乳期能不能打、用什么药，由医生决定。很少数打针也不好的，可以做一个小手术，把那段隧道切开。

腕管综合征：晚上戴护腕是第一步；严重的、护腕不管用的，可以考虑超声引导下打针，短期效果好，但研究的证据强度偏低[12]。需要手术的很少。

腰、骨盆、肩颈：一般不需要打针，以改动作和练习为主。

26 中医、针灸、推拿

很多妈妈会去做针灸、推拿、艾灸、拔罐。这些有没有用？

针灸：瑞典一项 386 位孕妇的随机试验发现，在常规治疗之外加针灸或加稳定练习，骨盆带痛都比只做常规治疗轻；针灸组晚上的疼痛最轻[34]。考克兰综述也说，单个研究提示针灸能改善孕期骨盆痛[29]。要说明：这些研究是**孕期**做的，不是产后；产后的针灸，编者没有找到同样质量的试验。

“产后身痛”的中药、艾灸：编者在 PubMed 上没有找到高质量的随机试验。不能说一定没用，只能说还没有可靠的证据。

推拿按摩：放松肌肉、让人舒服，可以作为辅助；但对慢性腰痛，研究资料不足以下结论[27]。手法太重、扳脖子，反而有风险。

> **编者的理解**
>
> 如果针灸、推拿让你舒服，又是在正规的医院做，可以作为辅助。但它们不能代替改抱法、改喂法和练习——那些才是在处理疼的来源。中药和偏方，哺乳期要先问医生（见第 24 章《止痛药：哺乳期能不能吃？》）。

27 睡眠：一家人接力

前面讲过，睡眠差会让疼痛更敏感、更难好[10]。产后睡眠被打断、睡不好，也是产后抑郁的危险因素[25]。所以，**让妈妈多睡一会儿，本身就是治疗。**

具体可以这样做：

- **夜里分班：**如果用奶瓶，丈夫或家人接一班夜奶（可以用吸出来的母乳），让妈妈连着睡四五个小时；纯母乳的，换尿布、拍嗝、哄睡交给家人，妈妈喂完就睡；

- **白天补觉：**孩子睡，妈妈也睡。家务可以放一放；
- **少看手机：**喂完奶不刷手机，尽快接着睡；
- **找个“替手”：**每天至少有一两段时间，孩子交给别人，妈妈完全歇一歇手。

编者的理解：在很多家庭里，“谁来带夜”是最难商量的事。但从这一篇的角度看，**它直接关系到妈妈的手、腰和心情能不能好起来。**

28 心情：疼和低落常常一起来

一篇汇总了 54 项研究、用正式诊断访谈的分析发现：产后一年内，约 **12.1%** 的妈妈有抑郁，约 7% 是重度抑郁；高峰在产后半年内[35]。

产后抑郁不只是“想哭”。它也可能表现为：

- 浑身酸痛、乏力、头痛；
- 孩子睡了自己也睡不着；
- 对什么都提不起兴趣，觉得自己是个不好的妈妈；
- 烦躁、易怒，或者一直很担心。

疼和低落，常常互相拉着：疼得厉害的妈妈更容易抑郁[11]，低落的时候疼也显得更重[2]。

如果这些情况持续两周以上，**请去医院**，很多医院产后复查时会用一份简单的问卷筛查。产后抑郁是能治的；在医生指导下，很多治疗也可以和哺乳兼顾。

对家人来说，最有用的不是说“想开点”，而是**接过手里的活，让她睡一觉，听她说一说。**

29 吃什么？补什么？

产后的饮食，本身就是一个大题目。这里只说和酸痛有关的几点：

- **补铁：**生产失血、哺乳都耗铁。查出贫血或缺铁，在医生指导下补铁，并多吃含铁的食物（红肉、动物血、深绿色蔬菜、豆类）。贫血纠正了，乏力和酸软常会好一些。
- **维生素 D：**查出不足就补；哺乳的妈妈本来也常被建议补充。
- **蛋白质和钙：**肌肉恢复需要蛋白质；哺乳期要保证奶类、豆制品等含钙的食物。
- **喝够水。**

要说明：编者没有找到研究证明某一种营养素或保健品能直接治好产后的关节肌肉酸痛。**营养是“地基”，不是“特效药”。**它不能代替改动作和练习。

第六部分

能不能好，要多久

30 大概多久会好？

这是小林最关心的问题。研究给的答案是：**大多数会一点点好起来。**

图 10 大概多久会好：多数会一点点好起来



Sit 2017、He 2023、Wu 2004、Burani 2023、Sperstad 2016

- **妈妈手：**香港的调查里，产后 2 个月八成多还在痛[1]——它不会自己很快消失，所以要主动处理。改抱法、戴护具，孩子大一些、抱得少了会减轻；打针后约七成多完全缓解[33]。
- **腕管综合征：**多在产后慢慢消退，有的要到断奶以后[17][18]。

- **腰痛和骨盆带痛：**产后约四分之一的妇女有，严重的约 7%[4]；多数在几个月内明显好转。挪威的试验里，做稳定练习的妇女到产后一年仍然好得多[28]。
- **腹直肌分离：**产后 6 周约 60%，一年后约 33%[7]。
- **肩颈：**跟着姿势走。换了姿势、缩短每次喂奶时间，常在几周里减轻（编者的理解）。

哪些人容易拖久？一篇系统综述发现：**孕期就疼得很厉害、以前腰痛过、功能受限很重的人，还有“很怕动”的人**，骨盆带痛更容易拖到产后三到六个月以后[36]。

编者的理解：如果按这一篇的办法做了**四到六周**，还是没有好转，或者越来越重，就去医院的康复科、骨科或手外科，请医生仔细查一查。

31 越怕动，越难好

那篇系统综述里，有一个预测因素特别值得说：**“恐惧回避”**——因为怕疼、怕“伤着”，就不敢动、处处躲着。它是产后骨盆带痛拖久的强预测因素之一[36]。

这和“月子病好不了”这句话，正好连在一起。一个妈妈听了这句话，就会想：“我这一辈子都这样了”“动一动会不会更坏”。于是不敢走、不敢练、不敢碰水，身体越来越弱，疼也越来越难好。

广州的研究也发现，每天走得多一点的妇女，骨盆带痛反而少一些[20]。

该怎样想：

- 疼，不等于“在受伤”。产后的酸痛，大多是累了、弱了的信号，不是骨头坏了；
- 动的时候有一点酸，是正常的；不让第二天更疼，就是合适的量；
- 一天比一天多走一点、多练一点，身体会跟上来。

小林那句“这种疼不像运动以后的酸，几天也消不掉”，是对的观察。它确实不是乳酸——是劳损，是身体还没恢复。**但这也正说明，它会随着负荷减轻、力量回来而好起来。**

第七部分

一家人一起

32 一家人一起，让妈妈少疼一点

读到这里会发现，很多办法，不是妈妈一个人能做到的。

图 11 一家人一起，让妈妈少疼一点



编者根据本篇引用的研究整理

给丈夫：抱孩子、拍嗝、换尿布、洗奶瓶、拧毛巾——这些最伤妈妈手腕的活，多接过来。夜里至少接一班。她说哪里疼的时候，不要说“谁生孩子不这样”，陪她去查一查。

给老人：老人的经验很宝贵，帮忙也很辛苦。只有两点请放下：一是不必逼着“捂”、不让洗澡（见第 8 章《碰了冷水、激素，是不是原因？》）；二是别说“月子病好不了”——这句话会让她更怕、更不敢动（见第 31 章《越怕动，越难好》）。

给朋友和教会的弟兄姐妹：送一顿饭，来帮着抱一会儿孩子，让她睡一个午觉。陪她说说话。

> 你们各人的重担要互相担当，如此，就完全了基督的律法。
>
> 加拉太书 6:2

33 结语：慢慢引导那乳养小羊的

两个月后，小林的手腕好多了。

她学会了手掌朝上托着抱孩子；喂奶时腿上放一个枕头，背后再垫一个；侧躺时把枕头换成高一点的。丈夫接过了夜里的那一班。每天趁孩子睡觉，她做十几分钟练习，推着婴儿车出去走半小时。

医生给她查了血，甲状腺、血常规、类风湿的指标都正常。“知道了不是别的病，心里就松了一半。”

胯还有一点酸，走多了会提醒她。但她不再怕了。“原来不是月子病，是我太累了，身体还没恢复。”

以赛亚书里有一句话，写的是上帝怎样照顾祂的百姓：

> 他必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的。
>
> 以赛亚书 40:11

“慢慢引导那乳养小羊的”——那些正在喂养小羊的母羊，牧人不催她们，走得慢一点。

编者的理解：产后的身体，也需要这样“慢慢”。不必急着恢复到从前，也不必害怕自己再也好不了。**减一减负荷，练一练力量，睡一睡觉，让家人分一分担子。**一点一点，会好起来的。

> 凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。
>
> 马太福音 11:28

再说一遍

这一篇是健康科普，不能代替医生的诊断和处方。手指脚趾小关节肿痛、早上僵硬很久、特别乏力怕冷或心慌，请去查血；一条腿肿痛、胸痛气短、发烧、手越来越没力气、心情一直很低落，请马上去医院。

这是“月子病”吗？能好吗？ —

医学上没有一个病叫月子病。产后的酸痛多是妈妈手、腕管综合征、姿势劳损、骨盆带痛这几种，各有原因和办法；大多数会一点点好起来。编者没有找到研究支持“月子病好不了”的说

法。

月子里碰了冷水，是不是落下了病根？

编者没有找到研究说明产后碰冷水会造成腱鞘炎或关节病。妈妈手主要是抱孩子的动作造成的[5]。产后洗温水澡也没有害处，反而减轻疲劳[14]。

出了月子才开始疼，为什么？

出了月子，往往正是妈妈开始自己带孩子的时候：抱、喂的次数多了，孩子越来越重，身体还没恢复，觉也睡不够。三股力量汇在一起。

拇指根、手腕疼，怎么分辨是不是妈妈手？

拇指弯进掌心、其余四指握住，手腕慢慢往小指方向弯，拇指一侧手腕剧痛，就很像妈妈手。请医生确认。

手指发麻怎么办？

先看麻在哪几根：拇指、食指、中指麻，夜里麻醒，多半是腕管综合征，晚上戴让手腕保持平直的护腕[12]；小指麻或伴肩颈痛、转头加重，要想到肘部或颈部。手越来越没力气，要看医生。

哺乳期能吃止痛药吗？

对乙酰氨基酚和布洛芬是哺乳期首选的止痛药[31]，按说明书短期吃，先问医生或药师。止痛膏不要抹在乳房附近。

妈妈手要打针吗？对孩子有没有影响？

改抱法、戴护具几周不好，可以请医生考虑打一针；汇总研究里打针比单纯戴护具效果好[32]。哺乳期能不能打、用什么药，由医生决定。

骨盆和胯疼，还能走路吗？

能，而且要走。广州的研究里，每天走得多一点的反而少一些[20]。办法是分几次走、每次少一点、步子小一点，同时练臀部和核心。

什么时候要去查血?

手指脚趾的小关节肿痛、两边对称、早上僵硬超过一小时；特别乏力怕冷或心慌手抖；体重变化大。可以查血常规、铁蛋白、甲状腺功能和抗体、血沉、C 反应蛋白、类风湿因子、抗 CCP 抗体、维生素 D。

多久能好?

多数在几个月里一点点好转；腕管综合征有的要到断奶以后。按这一篇的办法做了四到六周还没好转或越来越重，去医院的康复科、骨科或手外科。

读完了？把这一篇分享给需要的人，或者答 3 道小题，下载 PDF 留着慢慢读。

资料出处

本页引用的医学研究和指南，都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，附 DOI 或 PubMed 链接；本页只转述摘要和指南里的结论，数字以原文为准。外文引文的中文都是编者所译。经文用和合本。

资料在 2026 年 11 月逐一核对过；部分外国网站在中国大陆可能打不开。点 ↑ 回到正文引用的位置。

1. 官方网站 Sit RWS, et al. A Pilot Cross-Sectional Study of Postpartum Wrist Pain in an Urban Chinese Population: Its Prevalence and Risk Factors. Pain Physician 2017;20(5):E711-E719（香港中文大学；PubMed 28727715） pubmed.ncbi.nlm.nih.gov ↗ ↑ ↑ ↑
2. 学术研究 Li W, et al. Characteristics and effects on daily lives of pelvic girdle pain during early postpartum in Beijing women, China. Women Health 2024;64(4):330-340（北京 1,038 位产后 6 周的妈妈；PubMed 38556776） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
3. 学术研究 Ratajczak M, Górnowicz R. The influence of breastfeeding factors on the prevalence of back and neck pain: data from an online survey. BMC Musculoskelet Disord 2024;25(1):675（波兰 395 位哺乳妈妈；PubMed 39210354） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑
4. 学术研究 Wu WH, et al. Pregnancy-related pelvic girdle pain (PPP), I: Terminology, clinical presentation, and prevalence. Eur Spine J 2004;13(7):575-589（系统综述；PubMed 15338362） doi.org ↗ ↑ ↑
5. 官方网站 Ferraro E, et al. De Quervain's Tenosynovitis in Primary Caregivers. WMJ 2023;122(2):110-113（PubMed 37141474） pubmed.ncbi.nlm.nih.gov ↗ ↑ ↑ ↑ ↑
6. 学术研究 Manzoor A, et al. Prevalence of De Quervain disease in infant caregivers and its association with risk factors. J Pak Med Assoc 2024;74(7):1335-1337（PubMed 39028065）

doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

7. 学术研究 Sperstad JB, et al. Diastasis recti abdominis during pregnancy and 12 months after childbirth: prevalence, risk factors and report of lumbopelvic pain. Br J Sports Med 2016;50(17):1092-1096（挪威 300 位初产妇；PubMed 27324871） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑
8. 学术研究 Long Y, et al. Morphological and Functional Changes of Core Muscles in Postpartum Women With Low Back Pain Based on Musculoskeletal Ultrasound. J Clin Ultrasound 2025;53(8):1731-1740（中山大学附属医院；PubMed 40351194） doi.org ↗ ↑ ↑
9. 学术研究 Segal NA, et al. Pregnancy leads to lasting changes in foot structure. Am J Phys Med Rehabil 2013;92(3):232-240（PubMed 23117270） doi.org ↗ ↑ ↑
10. 学术研究 Finan PH, Goodin BR, Smith MT. The association of sleep and pain: an update and a path forward. J Pain 2013;14(12):1539-1552（综述；PubMed 24290442） doi.org ↗ ↑ ↑
11. 学术研究 Eisenach JC, et al. Severity of acute pain after childbirth, but not type of delivery, predicts persistent pain and postpartum depression. Pain 2008;140(1):87-94（1,288 位产妇；PubMed 18818022） doi.org ↗ ↑ ↑
12. 学术研究 Kumari O, et al. Conservative management of carpal tunnel syndrome during pregnancy and lactation: A systematic review of mixed study designs. J Clin Orthop Trauma 2026;82:103608（PubMed 42761408） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑
13. 学术研究 Daglan E, et al. Risk Factors Associated With de Quervain Tenosynovitis in Postpartum Women. Hand (N Y) 2024;19(4):643-647（PubMed 36692105） doi.org ↗ ↑ ↑
14. 学术研究 Hsieh CH, et al. Efficacy of Warm Showers on Postpartum Fatigue Among Vaginal-Birth Taiwanese Women: A Quasi-Experimental Design. Res Theory Nurs Pract 2017;31(2):96-106（台湾 358 位产妇；PubMed 28482991） doi.org ↗ ↑ ↑
15. 学术研究 Vo T, Desai M. Immigrant Southeast and East Asian mothers' transnational postpartum cultural practices: A meta-ethnography. Womens Health (Lond) 2021;17:17455065211060640（PubMed 34798791） doi.org ↗ ↑
16. 学术研究 Khama C, et al. "I couldn't change his nappy": New mothers' experiences of De Quervain's tendinosis and its impact on occupational performance. Aust Occup Ther J 2025;72(2):e70014（PubMed 40176482） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑
17. 官方网站 Atzmon R, et al. [Carpal tunnel syndrome in pregnancy]. Harefuah 2014;153(11):663-666（希伯来文综述，据英文摘要；PubMed 25563028） pubmed.ncbi.nlm.nih.gov ↗ ↑ ↑ ↑
18. 学术研究 Georgiew F, et al. Pregnancy-Related Carpal Tunnel Syndrome. Cureus 2025;17(10):e94652（综述；PubMed 41246673） doi.org ↗ ↑ ↑
19. 学术研究 Aburub A, et al. Nursing Mothers' Experiences of Musculoskeletal Pain Attributed to Poor Posture During Breastfeeding: A Mixed Methods Study. Breastfeed Med 2022;17(11):926-931（PubMed 36378819） doi.org ↗ ↑
20. 学术研究 He Y, et al. Risk factors for pregnancy-related pelvic girdle pain: A cross sectional study. Afr J Reprod Health 2025;29(5):36-52（广东省妇幼保健院 416 位孕晚期和产后妇女；PubMed 40445018） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

21. 学术研究 Nguyen CT, Mestman JH. Postpartum Thyroiditis. Clin Obstet Gynecol 2019;62(2):359-364（综述；PubMed 30844908） doi.org ↗ ↑ ↑

22. 学术研究 Samuels MH. Subacute, silent, and postpartum thyroiditis. Med Clin North Am 2012;96(2):223-233（综述；PubMed 22443972） doi.org ↗ ↑

23. 学术研究 Silman A, Kay A, Brennan P. Timing of pregnancy in relation to the onset of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1992;35(2):152-155（PubMed 1734904） doi.org ↗ ↑

24. 学术研究 Wallenius M, et al. Postpartum onset of rheumatoid arthritis and other chronic arthritides: results from a patient register linked to a medical birth registry. Ann Rheum Dis 2010;69(2):332-336（挪威；PubMed 19717397） doi.org ↗ ↑

25. 学术研究 Zhao XH, Zhang ZH. Risk factors for postpartum depression: An evidence-based systematic review of systematic reviews and meta-analyses. Asian J Psychiatr 2020;53:102353（PubMed 32927309） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

26. 学术研究 Kamel H, et al. Risk of a thrombotic event after the 6-week postpartum period. N Engl J Med 2014;370(14):1307-1315（美国加州 168 万次分娩；PubMed 24524551） doi.org ↗ ↑

27. 学术研究 van Middelkoop M, et al. A systematic review on the effectiveness of physical and rehabilitation interventions for chronic non-specific low back pain. Eur Spine J 2011;20(1):19-39（PubMed 20640863） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

28. 学术研究 Stuge B, et al. The efficacy of a treatment program focusing on specific stabilizing exercises for pelvic girdle pain after pregnancy: a randomized controlled trial. Spine 2004;29(4):351-359（PubMed 15094530） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

29. 学术研究 Liddle SD, Pennick V. Interventions for preventing and treating low-back and pelvic pain during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2015;(9):CD001139（考克兰综述；PubMed 26422811） doi.org ↗ ↑ ↑

30. 学术研究 Bull FC, et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Br J Sports Med 2020;54(24):1451-1462（世界卫生组织；PubMed 33239350） doi.org ↗ ↑

31. 官方网站 Spencer JP, et al. Medication Safety in Breastfeeding. Am Fam Physician 2022;106(6):638-644（PubMed 36521462） pubmed.ncbi.nlm.nih.gov ↗ ↑ ↑ ↑

32. 学术研究 Cevik J, et al. Corticosteroid injection versus immobilisation for the treatment of De Quervain's tenosynovitis: A systematic review and meta-analysis. Hand Surg Rehabil 2024;43(3):101694（PubMed 38642740） doi.org ↗ ↑ ↑

33. 学术研究 He KS, et al. Unblinding de Quervain: A systematic review of ultrasound-guided injection of corticosteroids for treatment of stenosing tenosynovitis of the 1st extensor compartment. J Med Radiat Sci 2023;70(3):319-326（PubMed 37078429） doi.org ↗ ↑ ↑

34. 学术研究 Elden H, et al. Effects of acupuncture and stabilising exercises as adjunct to standard treatment in pregnant women with pelvic girdle pain: randomised single blind controlled trial. BMJ 2005;330(7494):761（瑞典 386 位孕妇；PubMed 15778231） doi.org ↗ ↑

35. 学术研究 Bai Y, et al. Prevalence of Postpartum Depression Based on Diagnostic Interviews: A Systematic Review and Meta-Analysis. Depress Anxiety 2023;2023:8403222（PubMed 40224605） doi.org ↗ ↑

36. 学术研究 Burani E, et al. Predictive Factors for Pregnancy-Related Persistent Pelvic Girdle Pain (PPGP): A Systematic Review. Medicina (Kaunas) 2023;59(12):2123（PubMed 38138226） doi.org ↗ ↑ ↑

整理制作 · Ethan（HangZhou_XG） · 健康栏目 · 健康科普，不能代替医生的诊断和处方

← 回到健康 学课目录